

# UFSC – SC – 2011

## Residência Médica R1 – Prova 1

Prova com 100 questões · Documento gerado a partir de provaderesidencia.com.br

---

**1.** Mulher de 46 anos chega à Emergência relatando dor abdominal aguda no quadrante inferior direito. Como poderia diferenciar um quadro agudo de apendicite de uma ileíte aguda?

- A)** Leucocitose.
- B)** Presença de diarreia.
- C)** Biópsia por colonoscopia.
- D)** Espessamento de linfonodos mesentéricos à radiologia.
- E)** Desenvolvimento de dor aguda ou subaguda no quadrante inferior direito.

**2.** Um homem de 60 anos, alcoólatra crônico, foi internado com episódio de pancreatite aguda. Ele sofreu episódios semelhantes no passado e todos evoluíram sem complicações. Nos estudos laboratoriais foi encontrada amilase sérica elevada. Um pseudocisto pancreático de 4 cm foi encontrado na Tomografia. Qual poderia ser o melhor tratamento?

- A)** Aspiração simples.
- B)** Intervenção cirúrgica.
- C)** Drenagem percutânea.
- D)** Esclerose por radioterapia.
- E)** Observação e controle tomográfico periódico.

**3.** Em paciente com pancreatite aguda, o sinal de Cullen está localizado:

- A)** No dorso.
- B)** Nos flancos.
- C)** No ponto cístico.
- D)** Na região periumbilical.
- E)** Na fossa ilíaca esquerda.

**4.** Qual a etiologia mais comum que contribui para a ocorrência de lesão da via biliar durante a colecistectomia laparoscópica?

- A)** Obesidade.
- B)** Inflamação aguda ou crônica da vesícula biliar.
- C)** Tração excessiva da vesícula biliar em direção cefálica.
- D)** Anomalia anatômica congênita.
- E)** Sangramento.

**5.** No íleo biliar, o local mais frequente de impactação do cálculo é:

- A)** Proximal e próximo à válvula ileocecal.
- B)** Distal à válvula ileocecal.
- C)** Na transição jejunoileal.
- D)** Na válvula ileocecal.
- E)** No ângulo de Treitz.

**6.** Considere um paciente vítima de acidente automobilístico há 4 horas. No pronto-socorro, apresentou hipotensão arterial, que respondeu à infusão de cristaloides, e dispneia que melhorou após a colocação de cateter de oxigênio a 5 L/min. Os exames de imagem revelaram o diagnóstico de hérnia diafragmática traumática à esquerda. Qual a conduta mais apropriada no caso?

- A)** Videotoracosopia.
- B)** Laparotomia exploradora.
- C)** Toracotomia exploradora.
- D)** Observação clínica e cirurgia em um tempo posterior.
- E)** Drenagem do hemitórax esquerdo e sonda nasogástrica.

**7.** Um paciente do sexo masculino, 72 anos, dá entrada no SPA com dor em fossa ilíaca esquerda de início há 72 horas, diminuição da eliminação de gases e parada de eliminação de fezes. Ao exame físico, queixa-se de dor à palpação da FIE onde se palpa massa de contornos imprecisos, com cerca de 6/7 cm de diâmetro, bastante dolorosa. Bom estado geral. Exame ultrassonográfico mostra abscesso pericólico, de sigmoide e espessamento do intestino no local. O hemograma mostra série vermelha normal e 16.000 leucócitos com 80% de segmentados e 15% de bastões. Assinale a alternativa que indica o melhor tratamento.

- A)** Operação de Hartmann e antibioticoterapia.
- B)** Operação de Mickulicz, lavagem da cavidade peritonial e antibioticoterapia.
- C)** Sigmoidectomia, colorretoanastomose e antibioticoterapia.
- D)** Drenagem do abscesso por laparotomia e antibioticoterapia.
- E)** Drenagem do abscesso por punção dirigida por exame de imagem e antibioticoterapia.

**8.** A ultrassonografia é um método de imagem frequentemente utilizado no diagnóstico da colecistite aguda com índices de sensibilidade e especificidade respectivamente em torno de:

- A)** 85-95%.
- B)** 60-70%.
- C)** 50-70%.
- D)** 40-50%.
- E)** 30-35%.

**9.** Os colangiocarcinomas estão localizados, na sua maioria:

- A)** No ducto hepático.
- B)** No ducto colédoco.
- C)** No colédoco terminal.
- D)** Nos ductos intra-hepáticos.
- E)** Na bifurcação dos hepáticos.

**10.** São fatores de risco para o desenvolvimento do câncer gástrico, exceto:

- A)** Sexo masculino.
- B)** Pólipos adenomatosos.
- C)** Infecção por *Helicobacter pylori*.
- D)** Alto consumo de gorduras e proteínas.
- E)** Alto consumo de nitratos.

**11.** Com relação ao atendimento de um traumatizado, tomando como base a cinemática do trauma, é correto afirmar:

- A)** A magnitude do trauma independe da quantidade de energia cinética desprendida.
- B)** Nas lesões por projétil de arma de fogo, a distância entre o cano da arma e o alvo é dividida em: encostado (0-0,5 cm); queima-roupa (0,5-50 cm) e à distância (>50 cm).
- C)** A cinemática faz parte da mecânica e constitui-se na ciência que estuda os movimentos, dependendo da quantidade das forças que os produzem.
- D)** Num veículo parado que teve uma colisão traseira causada por outro veículo, o apoio para cabeça tem pouca relação com as lesões.
- E)** Os sérios impactos laterais não constituem importante causa de trauma de aorta torácica.

**12.** Nos corpos estranhos do trato digestivo alto, é correto afirmar:

- A)** Não se faz progressão dos mesmos para o estômago por via endoscópica.
- B)** A maioria dos corpos estranhos impacta no esôfago, principalmente no terço médio.
- C)** A ingestão de moedas é pouco frequente em crianças.
- D)** Nos casos de espinha de peixe, a radiografia simples tem alta sensibilidade (>70%).
- E)** 80-90% dos corpos estranhos progridem pelo trato digestivo e são eliminados espontaneamente.

**13.** Com relação à hemobilia, está correto afirmar:

- A)** Não é capaz de causar choque hemorrágico.
- B)** O pâncreas pode ser uma fonte de hemobilia.
- C)** A tríade clássica é descrita por Sandblom como dor, icterícia e hematêmese.
- D)** O sistema venoso é mais comumente acometido.
- E)** O colangiocarcinoma é o tumor que mais causa hemobilia.

**14.** É correto afirmar nas hérnias incisionais:

- A)** Divergem das hérnias ventrais.
- B)** O uso de esteroides não é um dos fatores causais.
- C)** A perda de peso não interfere na correção cirúrgica.
- D)** O reparo primário de uma hérnia incisional não deve ser realizado.
- E)** O fator causal mais comum no desenvolvimento de hérnias incisionais é a infecção pós-operatória na incisão.

**15.** A respeito dos casos de hematoma da bainha do músculo reto abdominal, pode-se afirmar:

- A)** Acomete com frequência crianças.
- B)** A proporção de mulher / homem é de 1:2 até 1:3.
- C)** A lesão do músculo reto abdominal ou dos vasos epigástricos inferiores parece ser o evento inicial.
- D)** Não é confundido com doenças intra-abdominais de urgência.
- E)** É conhecido desde 1857 com a descrição de Virchow.

**16.** Um paciente de 70 anos, sexo masculino, chega na Unidade de Emergência com quadro de hemorragia digestiva alta. O exame físico demonstra palidez, frequência cardíaca de 100 bpm e hipotensão com PAS entre 90 e 100 mmHg. Há 2 anos, diagnóstico de úlcera péptica e insuficiência coronariana. É correto afirmar:

- A)** Realizar alcoolização da lesão.
- B)** Estima-se que a perda sanguínea seja de 1500 ml.
- C)** O risco cirúrgico relacionado à idade e comorbidade justifica protelar ao máximo uma indicação cirúrgica.
- D)** Está indicado hemostasia endoscópica apenas quando há sangramento ativo no momento do exame.
- E)** A endoscopia digestiva alta deve ser a primeira conduta.

**17.** Em relação à avaliação nutricional do paciente cirúrgico, qual dos itens abaixo não contribui para o cálculo do gasto energético basal:

- A)** Idade.
- B)** Sexo.
- C)** Altura.
- D)** Peso.
- E)** Atividade metabólica.

**18.** Uma mulher de 45 anos chega ao Pronto Atendimento com queixa de dor abdominal, febre e urina escura. Tem como antecedente história de colecistectomia há 2 meses. Ao exame físico apresenta-se ictérica (++) e o leucograma exhibe leucocitose. Qual a primeira conduta a ser adotada?

- A)** Iniciar antibioticoterapia.
- B)** Providenciar ultrassonografia abdominal.
- C)** Encaminhar para colangiografia por ressonância magnética.
- D)** Aguardar resultado da hemocultura.
- E)** Afastar infecção.

**19.** A síndrome da embolia gordurosa tem incidência de 0,5 a 2% nos casos de fratura de ossos longos, podendo chegar a 10% nos casos de fratura bilateral de fêmur. Sobre os exames complementares nessa doença, assinale a alternativa incorreta.

- A)** A radiografia de tórax pode revelar achados patognomônicos da embolia gordurosa, como os sinais de Westmark, Palla e Hampton.
- B)** Na embolia gordurosa, o ecocardiograma mostra sinais de sobrecarga do ventrículo direito, com aumento de pressão da artéria pulmonar.
- C)** A presença de plaquetopenia é fundamental para a definição diagnóstica.
- D)** Na broscopia e lavado broncoalveolar podem ser encontrados macrófagos alveolares com gordura fagocitada.
- E)** A ressonância magnética cerebral é um exame bastante específico, podendo identificar áreas com gotículas de gordura circundadas de lesão isquêmica.

**20.** A abordagem cirúrgica da Pancreatite aguda grave ainda é um dos temas que mais gera controvérsias nos últimos anos, fundamentalmente no que diz respeito ao momento e tipo de cirurgia a ser realizada. Assinale a alternativa correta.

- A)** A intervenção cirúrgica precoce, de rotina, no diagnóstico da pancreatite aguda é seguida dos melhores resultados.
- B)** O abscesso pancreático acontece tardiamente, em torno de 4 a 6 semanas após o início do quadro. Seu tratamento é cirúrgico.
- C)** O tratamento da necrose pancreática infectada, confirmada por bacterioscopia positiva através de punção, é realizado de forma conservadora, com antibioticoterapia de longo espectro, como carbapenêmicos.
- D)** O aumento da pressão intra-abdominal acima de 20 mmHg pode trazer repercussões hemodinâmicas graves, inclusive com insuficiência renal. Esta situação deve ser manejada com diuréticos de alça e decúbito lateral.
- E)** O pseudocisto de pâncreas aparece tardiamente e o tratamento ideal é a laparotomia, devido ao alto risco de drenagem da endoscopia.

**21.** Em relação ao Crescimento Intrauterino Restrito (CIUR), assinale a alternativa correta.

- A)** No tipo assimétrico a alteração predominante é na fase de hiperplasia celular.
- B)** A causa mais comum de CIUR simétrico é a insuficiência placentária de causa vascular.
- C)** A cordocentese está indicada com mais frequência no tipo assimétrico.
- D)** Há associação entre o baixo peso ao nascer e a presença de hipertensão e de doença cardiovascular na vida adulta.
- E)** As infecções congênitas associadas ao CIUR são tardias e determinam mais o tipo assimétrico.

**22.** Uma mulher com hipotireoidismo, fazendo uso de levotiroxina sódica, 75 mg/dia, comparece à primeira consulta do pré-natal, assintomática, trazendo dosagem do TSH de 8,6 mU/L. Qual a conduta correta?

- A)** Aumentar a dose da levotiroxina.
- B)** Interromper o tratamento com a levotiroxina e acompanhar a evolução do TSH, pois um leve aumento do TSH é fisiológico no início da gravidez.
- C)** Substituir a levotiroxina pelo metimazol.
- D)** Manter a dose da medicação.
- E)** Solicitar anticorpos antitireoidianos e persistir com o tratamento, aumentando a dose da medicação apenas se os anticorpos forem positivos.

**23.** O tratamento de escolha para a gestante com síndrome antifosfolípido é:

- A)** Interferon e ácido fólico.
- B)** Enoxaparina e betametasona.
- C)** Imunoglobulina e ácido fólico.
- D)** Heparina e ácido acetilsalicílico.
- E)** Prednisolona e ácido acetilsalicílico.

**24.** Uma mulher com hipertensão arterial crônica leve, fazendo uso de captopril 25 mg duas vezes ao dia, comparece à primeira consulta do pré-natal, ainda no primeiro trimestre. Qual a conduta indicada, de acordo com os critérios da medicina baseada em evidências?

- A)** Substituir o captopril por um diurético.
- B)** Substituir o captopril pela alfametildopa.
- C)** Substituir o captopril pela hidralazina oral.
- D)** Manter o captopril, pois a paciente encontra-se adaptada à medicação.
- E)** Interromper a terapia medicamentosa anti-hipertensiva e observar a evolução dos níveis tensionais.

**25.** Perante uma distócia biacromial, qual a manobra recomendada inicialmente?

- A)** Clidotomia.
- B)** Hiperflexão e abdução das coxas.
- C)** Rotação do ombro posterior, 180°, no sentido horário.
- D)** Hiperextensão da coxa, com compressão suprapúbica.
- E)** Apreensão e deslizamento do antebraço posterior.

**26.** Uma gestante comparece ao hospital com idade gestacional confirmada de 42 semanas, assintomática, perfil biofísico fetal (PBF) 10, sem atividade uterina, índice de Bishop 1, apresentação cefálica, segunda gestação, com cesariana anterior há quatro anos por apresentação pélvica. Qual a conduta correta?

- A)** Indicar processo de indução de parto, iniciando com a colocação de um cateter de Foley transcervical, com balão insuflado, para preparo do colo.
- B)** Iniciar indução com misoprostol, via vaginal, na dose de 25 mcg de 6 em 6 horas.
- C)** Cesariana, após jejum de 8 horas.
- D)** Controle com PBF a cada 48 horas.
- E)** Definir conduta de acordo com a avaliação com Dopplervelocimetria.

**27.** Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas relacionadas ao cordão umbilical e placenta: ( ) O cordão umbilical pode ter inserção placentária central, intermediária ou periférica. ( ) A inserção na borda placentária configura a denominada placenta em raquete. ( ) Inserção velamentosa ocorre quando a inserção placentária é substituída por implantação nas membranas. ( ) As inserções centrais são as mais frequentes e o cordão umbilical apresenta comprimento médio de 80 cm. Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- A)** V – F – F – F.
- B)** V – V – F – F.
- C)** V – V – V – F.
- D)** F – V – V – V.
- E)** F – F – V – V.



**28.** Identifique se são Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as afirmativas relacionadas à ocitocina: ( ) A ocitocina tem um importante papel no determinismo do parto. ( ) É extremamente importante no período expulsivo e no secundamento. ( ) A concentração plasmática de ocitocina aumenta com a proximidade do parto. ( ) Ocorre um acentuado aumento de receptores de ocitocina nas células miométriais na gestação a termo, muito provavelmente devido à ação de estrógenos. Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- A)** F – V – F – V.
- B)** V – F – V – F.
- C)** F – F – F – F.
- D)** V – V – V – V.
- E)** F – F – V – V.

**29.** O útero durante a gestação aumenta de tamanho e de peso, torna-se amolecido e menos móvel; portanto, ao toque vaginal combinado fica mais fácil prendê-lo. Este sinal encontrado na propedêutica da gravidez é corretamente denominado:

- A)** Kluge.
- B)** Hegar.
- C)** Holzapfel.
- D)** Jacquemier.
- E)** Piskacek.

**30.** O principal fator predisponente na etiologia do descolamento prematuro da placenta é:

- A)** Trauma abdominal.
- B)** Hipertensão materna.
- C)** Brevidade do cordão umbilical.
- D)** Cirurgia uterina prévia.
- E)** Diabetes gestacional.

**31.** Sobre cancro mole, é correto afirmar:

- A)** Afecção causada pelo Herpes simplex virus, caracterizada por lesões não dolorosas e ausência de exsudato purulento fétido.
- B)** Afecção causada pelo *Calymmatobacterium granulomatis*, caracterizada por lesões dolorosas, granulomatosas e destrutivas.
- C)** Afecção causada pela *Chlamydia trachomatis*, caracterizada por lesões não dolorosas, inicialmente pápulas e que evoluem para pústulas ou exulceração genital.
- D)** Afecção causada pelo *Haemophilus ducreyi*, caracterizada por lesões dolorosas e exsudato purulento fétido.
- E)** Afecção causada pelo *Mycoplasma* e *Ureaplasma*, caracterizada por lesões dolorosas e ausência de exsudato purulento.

**32.** Analise o texto abaixo: Na vaginose bacteriana, o corrimento vaginal apresenta pH ..... que 4,5 e ..... de lactobacilos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto.

- A)** maior; diminuição.
- B)** maior; aumento.
- C)** igual; aumento.
- D)** menor; aumento.
- E)** menor; diminuição.

**33.** Considerando a Lei de Crimes Hediondos (Lei número 12.015, em vigor desde 7 de agosto de 2009), que prevê o aumento das penas para casos de estupro e pedofilia, é correto afirmar que o estupro é:

- A)** Constranger a mulher indefesa, mediante violência ou grave ameaça, à conjunção carnal.
- B)** Constranger alguém a praticar ou permitir ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
- C)** Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude.
- D)** A violência sexual cometida em vítima menor de 14 anos, alienada ou débil mental, ou quando não pode oferecer resistência.
- E)** Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

**34.** Indique o tratamento mais eficaz para o vaginismo:

- A)** Antidepressivos.
- B)** Toxina botulínica.
- C)** Psicanálise clássica.
- D)** Terapia de base comportamental.
- E)** Relaxantes musculares e ansiolíticos.

**35.** Qual dos medicamentos abaixo tem efeito predominante negativo sobre a resposta sexual?

- A)** Alfametildopa.
- B)** Bromoergocriptina.
- C)** Bupropiona.
- D)** Selegilina.
- E)** Testosterona.

**36.** É considerado precursor da dehidroepiandrosterona, a partir do colesterol:

- A)** Estrona.
- B)** 17-OH-Progesterona.
- C)** 17-OH-Pregnenolona.
- D)** (Delta) 4 progesterona.
- E)** Androstenediona.

**37.** Qual a melhor fase do ciclo menstrual para realização de ultrassom transvaginal, visando avaliação do endométrio?

- A)** 1º ao 5º dia.
- B)** 7º ao 12º dia.
- C)** 15º ao 20º dia.
- D)** 20º ao 25º dia.
- E)** Em qualquer período.

**38.** Considerando-se as variações hormonais ao longo do ciclo menstrual, assinale a alternativa correta:

- A)** LH e FSH estão elevados no início da fase folicular.
- B)** O pico de ovulação ocorre aproximadamente 12 horas após o pico de LH.
- C)** Inibina-A, secretada pelo folículo, estimula secreção de gonadotrofina.
- D)** Os níveis de estrogênio diminuem no início da fase lútea, imediatamente antes da ovulação e aumentam a partir do meio da fase lútea, como resultado da secreção do corpo lúteo.
- E)** Progesterona e estrogênio estimulam a secreção de gonadotrofinas no final da fase lútea e um novo folículo inicia crescimento.

**39.** Assinale a alternativa correta referente à endometriose:

- A)** A dosagem sérica do CA-125 é importante para diagnóstico da doença.
- B)** Supressão da função ovariana é efetiva na melhora da fertilidade.
- C)** Endometriose é definida como a presença de glândulas endometriais fora do útero.
- D)** Endometriose é diagnosticada pela inspeção visual da pelve durante laparoscopia, não sendo necessária a comprovação histológica por biópsia.
- E)** O sistema utilizado para classificação da endometriose é subjetivo e está pobremente relacionado com a dor, mas é valioso para determinar prognóstico e manejo da infertilidade.

**40.** Constitui achado normal no exame do colo uterino:

- A)** Mosaico.
- B)** Pontilhado.
- C)** Epitélio acetobranco.
- D)** Área de epitélio metaplásico.
- E)** Vasos em forma de saca-rolhas.

**41.** Gestante sem realização de pré-natal é admitida na maternidade em avançado trabalho de parto. O nascimento ocorre logo após a realização de dois testes rápidos anti-HIV, com resultado positivo. Assinale a alternativa com as medidas recomendadas para o recém-nascido:

- A)** Proscriver aleitamento materno, iniciar AZT oral no primeiro dia de vida e sulfametoxazol + trimetoprim no segundo dia.
- B)** Banho imediato após o nascimento, iniciar AZT em solução oral até duas horas de vida e proscrever aleitamento materno.
- C)** Medidas de rotina. Como a mãe não recebeu AZT endovenoso antes do parto, medidas específicas para o recém-nascido não modificam o risco de transmissão.
- D)** Aguardar o resultado de exame sorológico confirmatório materno para iniciar AZT e proscrever aleitamento materno.
- E)** Banho após o nascimento com clorexidina 2%, AZT endovenoso por três horas, seguido da solução oral em intervalos de 6/6 horas.

**42.** Em relação à sepse bacteriana neonatal precoce, é correto afirmar:

- A)** O tratamento de criança estável hemodinamicamente poderá ser enteral.
- B)** Streptococcus  $\beta$ -hemolítico do grupo B é o principal agente etiológico e o esquema antibiótico inicial deve ser Cefazolina e Ampicilina.
- C)** A profilaxia com Penicilina intraparto reduz sua ocorrência e está indicada às mulheres colonizadas por Streptococcus do grupo B, mesmo na ausência de outro fator de risco.
- D)** Para diagnóstico, o hemograma possui elevado fator preditivo positivo, sendo a leucocitose a alteração mais frequentemente associada.
- E)** Recém-nascidos pré-termos têm risco aumentado para a sua ocorrência e agentes etiológicos diferentes; portanto, a antibioticoterapia inicial não pode ser semelhante à de recém-nascidos a termo.

**43.** Um lactente com 10 dias de vida, do sexo masculino, é encaminhado ao ambulatório de dermatologia pediátrica por apresentar, na pele, lesões tipo escamas, gordurosas de cor amarelada, sobre base eritematosa, localizadas em couro cabeludo, face, supercílios, orelhas, dobras de pescoço e axilar. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico:

- A)** Psoríase.
- B)** Dermatite seborreica.
- C)** Lúpus eritematoso sistêmico.
- D)** Dermatite atópica.
- E)** Líquen nítido.

**44.** Qual doença deve ser considerada pelo médico pediatra que, ao examinar um lactente, encontra lesões hipocrômicas em forma de folha na pele?

- A)** Sífilis congênita.
- B)** Neurofibromatose.
- C)** Esclerose tuberosa.
- D)** Epidermolise bolhosa congênita.
- E)** Síndrome da pele escaldada estafilocócica.

**45.** Em relação às infecções bacterianas da pele, todas as alternativas estão corretas, exceto:

- A)** Um dos mecanismos de defesa da pele é seu alto pH em torno de 7,5.
- B)** Os *Staphylococcus Aureus* habitam as fossas nasais anteriores de pessoas sadias por um período de tempo variável, podendo ser fonte de contaminação.
- C)** Os ácidos graxos insaturados, que constituem a secreção sebácea, atuam como bactericida.
- D)** O *Streptococcus beta-hemolítico* faz parte da flora endógena do homem.
- E)** *Haemophilus influenzae*, *Corynebacterium diphtheriae* e *Escherichia coli* também podem ser responsáveis por infecções cutâneas.

**46.** Uma adolescente de 14 anos é atendida em companhia da mãe, com a queixa de que é a única menina da classe que ainda não menstruou. Iniciou telarca e pubarca aos 12 anos, tendo crescido bem no período. O exame clínico é normal com desenvolvimento puberal com classificação de Tanner P4 e M4. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar:

- A)** Trata-se de Síndrome de Turner.
- B)** Provável hipotireoidismo subclínico.
- C)** A puberdade tem evolução normal, não requerendo investigação.
- D)** Provável Síndrome dos Ovários policísticos, necessitando reposição hormonal.
- E)** É necessário realizar ultrassonografia pélvica e avaliação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovário.

**47.** Identifique se as afirmativas abaixo sobre adolescência são verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) A adolescência é um fenômeno que se inicia aos 12 anos e termina aos 18 anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. ( ) A tendência grupal e a busca da identidade fazem parte da evolução psicossocial normal da adolescência, não sendo consideradas psicopatologias. ( ) As meninas têm o estirão do crescimento do meio para o final do desenvolvimento puberal; os meninos, no início da puberdade. ( ) As vacinas preconizadas na adolescência são HPV, Hepatite A e B, Varicela, Rubéola, Meningite C e reforço da Dupla Tipo adulto ou dTpa. ( ) As causas externas são a principal causa de mortalidade nessa faixa etária. Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- A)** F – V – V – V – V.
- B)** V – F – V – V – V.
- C)** V – V – V – F – V.
- D)** V – V – F – V – V.
- E)** V – V – V – V – F.

**48.** No período de pós-parto imediato, as mães, principalmente primíparas, ficam muito vulneráveis e inseguras em relação à alimentação de seus filhos. O profissional que atende esta puérpera deve orientá-la que a produção plena de leite (cerca de 600 ml/dia) ocorre no:

- A)** Primeiro dia de vida (até 24h).
- B)** Segundo dia de vida (24 a 48h).
- C)** Terceiro dia de vida (48 a 72h).
- D)** Quinto dia de vida (entre 96 e 120h).
- E)** Final do primeiro mês (cerca de trinta dias).

**49.** Do esquema vacinal da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis para o primeiro ano de vida, qual é a vacina que com maior frequência apresenta febre (acima de 38°C) como reação sistêmica após a aplicação?

- A)** Varicela.
- B)** Hepatite B.
- C)** Tetravalente (DPT + Hib).
- D)** Tríplice viral (sarampo/caxumba/rubéola).
- E)** Rotavírus.

**50.** Lactente de 4 meses de idade apresenta, há 5 dias, tosse produtiva, coriza e febre, com progressiva dificuldade respiratória e de alimentação. Ao exame físico constata-se tiragens torácicas moderadas, sibilos e estertores grossos bilaterais, sem melhora significativa após uso de broncodilatador. Ao RX de tórax, evidencia-se hiperinsuflação pulmonar difusa bilateral. Qual é o diagnóstico provável?

- A)** Asma.
- B)** Bronquiolite Viral Aguda.
- C)** Pneumonia bacteriana.
- D)** Laringotraqueobronquite.
- E)** Tuberculose pulmonar.

**51.** Numa reanimação cardiopulmonar em criança cardiopata que apresentou parada cardiorrespiratória em fibrilação ventricular, qual a droga a ser utilizada após a primeira tentativa de desfibrilação?

- A)** Epinefrina.
- B)** Amiodarona.
- C)** Lidocaína.
- D)** Verapamil.
- E)** Atropina.

**52.** No diagnóstico da Faringoamigdalite Viral em uma criança, o dado mais importante é:

- A)** Febre alta (39 a 40°C).
- B)** Idade inferior a dois anos.
- C)** Idade superior a dois anos.
- D)** Adenomegalia cervical dolorosa.
- E)** Presença de dor abdominal e vômitos.



**53.** Considere um menino de 5 anos, há 4 dias com edema doloroso de tornozelos, há 3 dias com lesões em membros inferiores. Sem febre. Apresentou dor abdominal, resolvida. Ao exame físico apresenta-se em BEG, com artrite de tornozelos e lesões purpúricas em nádegas e membros inferiores. PA = 85 × 55 mmHg. Hemograma: Hb = 12,5 g/dl; Ht = 37 %; VCM = 81 fl; leucócitos totais = 8.000/mm<sup>3</sup> ; Plaquetas = 290.000/mm<sup>3</sup>. Creatinina: 0,5 mg/dl. Parcial de urina sem alterações. A terapêutica inicial indicada é:

- A)** Furosemida.
- B)** Prednisolona.
- C)** Ciclofosfamida.
- D)** Gamaglobulina.
- E)** Analgésico comum.

**54.** Qual das alternativas abaixo não corresponde a um critério diagnóstico da doença de Kawasaki?

- A)** Febre.
- B)** Exantema.
- C)** Hepatoesplenomegalia.
- D)** Hiperemia conjuntival.
- E)** Edema de mãos e pés.

**55.** Um recém-nascido com 18 dias de vida é atendido no ambulatório. Sua mãe queixa-se de diarreia profusa com 7 evacuações líquidas por dia, espumosas e amareladas. Seu peso de nascimento foi 2.920 g e, no momento, encontra-se com 3.200 g. Sua alimentação é leite materno exclusivo. A conduta adequada para este caso é:

- A)** Continuar aleitamento materno exclusivo.
- B)** Oferecer leite de fórmula sem lactose.
- C)** Fazer pausa alimentar de 4 a 6 horas.
- D)** Realizar reidratação venosa.
- E)** Iniciar dieta obstipante.

**56.** Você pode encontrar em uma criança saudável, com 4 meses de idade, as seguintes características:

- A)** senta sem apoio; faz pressão plantar; tem reflexo da marcha.
- B)** muda de decúbito; sustenta a cabeça; apresenta vocalização social.
- C)** tem reflexo de Moro bem desenvolvido; sorri socialmente; senta com apoio.
- D)** emite pequenos sons guturais; passa um cubo de uma mão para outra; brinca com os pés.
- E)** acompanha objetos até a linha média; sustenta a cabeça; mantém as mãos bem fechadas.

**57.** Qual o ritmo de parada cardíaca mais comum na criança, sua causa e qual a droga de escolha para o tratamento?

- A)** Fibrilação ventricular; choque séptico; atropina.
- B)** Fibrilação ventricular; hipóxia; adrenalina.
- C)** Bradicardia/assistolia; hipóxia; atropina.
- D)** Bradicardia/assistolia; hipóxia; adrenalina.
- E)** Bradicardia/assistolia; choque hipovolêmico; adrenalina.

**58.** Você é chamado na unidade de internação pediátrica para avaliar um paciente com quatro anos, com quadro de pneumonia, já em uso de penicilina cristalina há quatro dias, mas que continua tendo febre diária de 39°C, sonolenta, saturando 80% em máscara não-reinalante com fluxo de O<sub>2</sub> de 15 l/min, com grave esforço respiratório, TIC, TSC, tiragem de fúrcula, batimento de asa de nariz, palidez acentuada, FR = 100 ipm, FC = 200 bpm, PA = 70 × 30 mmHg. Presença de estertores bilaterais. Bulhas taquicárdicas, com sopro sistólico III / VI em todos os focos. Tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Qual a conduta mais adequada?

- A)** Fazer alíquotas de 20 ml/kg de cristaloide, intubá-lo com COT 4, iniciar dopamina, colher culturas e solicitar Rx de tórax e encaminhar para UTI.
- B)** Manter máscara não-reinalante e aumentar o fluxo para 15 l/min, fazer Rx de tórax. Tentar puncionar tórax para afastar possível pneumotórax.
- C)** Posicionar vias aéreas, aspirar, colocar em CPAP nasal, sedar, desfibrilar com 2 J/kg, solicitar Rx de tórax, trocar antibiótico e colher culturas.
- D)** Posicionar vias aéreas, aspirar, intubar com COT 4, iniciar dobutamina 10 mcg/kg/min; fazer 20 ml/kg de cristaloide, colher culturas, trocar antibiótico e encaminhar para UTI.
- E)** Posicionar vias aéreas, aspirar, intubação traqueal com COT 5, usando a sequência rápida, ventilar, fazer alíquotas de 20 ml/kg de cristaloide, colher exames (culturas, HMG, eletrólitos, gasometria, PCR), fazer Rx de tórax, trocar antibiótico e encaminhar para UTI.

**59.** Sobre a paralisia cerebral hemiplégica, assinale a alternativa correta:

- A)** É o tipo de paralisia cerebral mais frequente nos prematuros.
- B)** É um dos tipos de paralisia cerebral associado à anóxia perinatal, com antecedente de baixos índices de Apgar.
- C)** Tem como principal etiologia os acidentes vasculares encefálicos isquêmicos no feto ou recém-nascido.
- D)** As funções mentais, incluindo linguagem, estão comprometidas. Quando essas funções estão preservadas, o diagnóstico de paralisia cerebral hemiplégica não pode ser feito.
- E)** Kernicterus, ou encefalopatia bilirrubínica, é um antecedente comum.

**60.** Um menino de sete anos, previamente sadio, é trazido ao serviço de emergência às 17h de um domingo. Os pais contam que brincava normalmente até às 15h, quando queixou-se de forte dor de cabeça e começou a vomitar. Ficou progressivamente sonolento e às 16h apresentou uma convulsão tônico-clônica generalizada que durou 5 minutos e cedeu sem anticonvulsivantes. Em seguida foi levado ao hospital pelo SAMU. Na admissão, o Glasgow era de 9 e apresentava hemiparesia direita. Depois das medidas de estabilização (ABC), qual dos seguintes procedimentos é prioritário?

- A)** Administração de manitol na dose de 1 g/kg.
- B)** Tomografia computadorizada de crânio sem contraste.
- C)** Administração de fenitoína na dose de 20 mg/kg diluída em solução fisiológica, em 20 minutos.
- D)** Punção lombar com raquimanometria após sedação com midazolam.
- E)** Ressonância magnética de crânio com angiografia.

**61.** Sobre a Estratégia Saúde da Família no Brasil, assinale a alternativa correta.

- A)** Tem caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- B)** As equipes de saúde da família devem manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a visitação e o atendimento clínico domiciliar rotineiro de todos os usuários adscritos.
- C)** Visa estimular os municípios a organizarem serviços de saúde para população abaixo da linha de pobreza, pois estão em áreas de prioridade social.
- D)** Efetiva a integração de ações programáticas, ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e vigilância, encaminhando a demanda espontânea à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de referência.
- E)** Desenvolve ações de tratamento, prevenção, promoção e reabilitação para a população adscrita nos seus problemas clínicos mais comuns, para todas as idades, encaminhando para a UPA as urgências e os pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

**62.** Considerando que a taquicardia está sempre presente em pacientes com hipertireoidismo, avalie a presença deste sinal como se fosse um teste diagnóstico, e assinale a alternativa correta.

- A)** O sinal é 100% sensível.
- B)** O sinal é 100% específico.
- C)** A presença do sinal diagnostica a doença.
- D)** A ausência do sinal não exclui a doença.
- E)** Não há resultados falso-positivos.

**63.** Um exame para detectar certo tipo de câncer apresenta uma sensibilidade de 80% e uma taxa de falso-positivos de 2%. Se uma população de 5000 pessoas, em que a prevalência deste câncer é de 1%, for submetida ao teste:

- A)** Haverá 1/4 dos pacientes doentes (com câncer) com resultados falso-negativos.
- B)** Haverá cerca de 2,5 resultados falso-positivos para cada verdadeiro-positivo.
- C)** Haverá 40 resultados falso-negativos.
- D)** Haverá 139 resultados negativos.
- E)** Haverá mais resultados verdadeiro-positivos do que falso-positivos.

**64.** Considere a relação médico-paciente e seus requisitos éticos em duas situações comuns, que coexistem proximamente, às vezes na mesma pessoa: 1. O paciente está assintomático e veio por outro problema. 2. O paciente está sentindo-se mal e doente, relatando sinais e sintomas. Assinale a alternativa correta.

- A)** A tolerância quanto a possíveis danos decorrentes da ação médica é semelhante nas duas situações.
- B)** As situações 1 e 2 são iguais eticamente quanto ao resultado das intervenções propostas.
- C)** As situações 1 e 2 são diferentes eticamente quanto à garantia de resultados das intervenções propostas.
- D)** O compromisso ético da relação na situação 1 não exige que o médico garanta benefícios quanto ao resultado das intervenções propostas.
- E)** O compromisso ético da relação na situação 2 exige que o médico possa garantir benefícios quanto ao resultado das intervenções.

**65.** Assinale a alternativa correta, quanto aos rastreamentos.

- A)** Os testes utilizados devem ter poucos falso-positivos.
- B)** O diagnóstico precoce é o objetivo final do rastreamento.
- C)** O câncer de mama pode ser prevenido e sua incidência diminuída com o uso da mamografia.
- D)** O rastreamento de fenilcetonúria não está indicado porque a doença é pouco prevalente.
- E)** O rastreamento de câncer de pulmão com Rx de tórax diminui a mortalidade por esta doença.

**66.** Assinale a alternativa correta, quanto aos tipos de prevenção.

- A)** Aconselhar para que se deixe de fumar é prevenção secundária.
- B)** Indicar exercícios físicos para paciente com artrite reumatoide é prevenção primária.
- C)** Ministras palestra na comunidade para evitar o cólera é prevenção secundária.
- D)** Indicar AAS (ácido acetilsalicílico) diariamente para paciente com doença arterial coronariana é prevenção terciária.
- E)** Em uma consulta, não solicitar um exame de rastreamento se não há fundamento para sua realização, pode ser caracterizado como prevenção quaternária.

**67.** Um paciente assintomático foi a uma consulta para um “check up”. Ao fim do atendimento o médico solicitou exames. O paciente regressou com uma glicemia de 140 mg/dl. O médico fez diagnóstico de diabetes e indicou iniciar uma dieta. Em duas semanas o paciente retornou ao médico com nova glicemia de 100 mg/dl. Assinale a alternativa correta sobre essa situação.

- A)** O médico devia ter começado o tratamento com medicação via oral.
- B)** Esse é um bom exemplo da eficácia da dieta no tratamento do diabetes.
- C)** Como tratamento inicial para a diabete, o médico devia ter orientado também uma rotina de atividade física para o paciente associada à dieta.
- D)** Pode ter ocorrido um fenômeno de regressão à média e a nova glicemia pode não ter relação com a dieta.
- E)** O médico atuou de forma adequada e o paciente se beneficiou com o enfoque dado ao problema.

**68.** Assinale a alternativa correta.

- A)** Deslocando-se o ponto de corte de um teste para diagnose de uma doença não se alteram as características do teste (especificidade e sensibilidade).
- B)** Um teste altamente sensível é muito importante quando o resultado dá positivo (confirma a doença).
- C)** Um teste altamente específico é muito importante quando o resultado dá negativo (descarta a doença).
- D)** A prevalência e as características de uma doença (letalidade, gravidade, significado epidemiológico, significado social etc.) não são importantes na investigação diagnóstica, pois não devem interferir na decisão do médico.
- E)** Para avaliação de uma doença com prevalência muito baixa num paciente (com sintomas) é preferível solicitar um exame muito específico, já que a possibilidade de rotular pacientes saudáveis como doentes é grande.

**69.** Um jovem de 17 anos, sem fatores de risco para qualquer doença, consulta porque a academia de ginástica pediu um check up que inclui o teste para HIV. Considerando que a sensibilidade do teste é 96%, a especificidade é 98%, e que a prevalência do HIV é 0,1%, assinale a alternativa correta.

- A)** O médico deve pedir o exame, pois o valor preditivo positivo é 0,99.
- B)** Se este exame for realizado em 100 mil doadores de sangue, dos 2094 exames positivos teremos 1998 verdadeiro-positivos.
- C)** Se o médico pedir o exame e este der positivo, a probabilidade de que seja um verdadeiro-positivo é de cerca de 4,5%.
- D)** O valor preditivo negativo é aproximadamente de 0,045, significando que se o exame der negativo a chance de ser um verdadeiro-negativo é muito grande.
- E)** Este exame é valioso na triagem num banco de sangue para avaliação do sangue de doadores porque apenas 4 em quase 100 mil indivíduos serão falso-positivos.

**70.** Quanto aos vícios (vieses) nas evidências e estudos sobre rastreamentos, assinale a alternativa correta.

- A)** A sobrevida é sempre um critério melhor para avaliar um rastreamento do que a mortalidade.
- B)** Viés de duração é quando o intervalo entre os testes de rastreamento seleciona um subgrupo de menor rapidez na evolução, piorando o prognóstico.
- C)** Viés de seleção é quando na seleção do grupo rastreado há pessoas que são representativas da população em geral.
- D)** Viés de antecipação é quando um estudo de rastreamento mostra que a sobrevida aumentou, mas esse aumento foi devido a uma antecipação do diagnóstico e não a uma melhoria na sobrevida geral do doente.
- E)** A baixa proporção de falso-positivos no rastreamento de uma doença de baixa prevalência é uma fonte de vieses importante na avaliação de um rastreamento.

**71.** Sobre o famoso Relatório Flexner, que influenciou fortemente a educação médica no início do século XX e até hoje, assinale a alternativa correta.

- A)** Priorizou uma educação médica voltada para os aspectos biológicos dos adoecimentos, centrando-a no ambiente laboratorial e hospitalar.
- B)** Induziu fortemente uma melhora na abordagem dos aspectos psicossociais dos adoecimentos.
- C)** Introduziu a medicina baseada em evidências, como a conhecemos hoje, no ensino médico.
- D)** Facilitou a preparação dos médicos para as dificuldades da relação médico-paciente e da missão de promoção da saúde da prática médica.
- E)** Dificultou a cientificização da medicina e a especialização da prática médica, ao enfatizar o ensino em hospitais-escola.

**72.** Segundo a Lei 8142/90, que regulamenta o funcionamento e a composição dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal), a participação popular no controle e na fiscalização da gestão do SUS se dá através da representação dos usuários nos Conselhos e Conferências, cujos representantes detêm:

- A)** 1/3 dos votos nessas instâncias, ficando 1/3 para a representação do governo e 1/3 para os representantes dos profissionais de saúde.
- B)** 1/3 dos votos nessas instâncias, ficando 1/3 para a representação do governo e 1/3 para os representantes dos prestadores de serviço.
- C)** 1/4 dos votos nessas instâncias, ficando 1/4 para a representação do governo e 1/4 para os representantes dos profissionais de saúde e 1/4 para os prestadores de serviço.
- D)** a metade dos votos, ficando a outra metade distribuída entre os profissionais de saúde e o governo.
- E)** a metade dos votos nessas instâncias, ficando a outra metade distribuída entre representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.

**73.** A gestão e a execução das ações de saúde no nível da Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde no Sistema Único de Saúde é de competência e responsabilidade do governo:

- A)** No nível municipal.
- B)** No nível estadual.
- C)** No nível municipal e estadual.
- D)** No nível federal.
- E)** Em qualquer nível de governo.



**74.** Assinale a alternativa correta.

- A)** O movimento da reforma sanitária brasileira defendia a integração dos hospitais de caridade, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPS) e do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS).
- B)** A reforma sanitária brasileira foi vetada pelos militares na época da ditadura e seus proponentes, perseguidos e torturados. Só após a Constituinte de 1988 foram esboçados os princípios norteadores da posterior formulação do SUS.
- C)** O movimento da reforma sanitária brasileira era liderado pela categoria médica, principalmente a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, com o apoio da Federação Brasileira dos Hospitais.
- D)** Uma das principais bandeiras de luta do movimento da reforma sanitária era o credenciamento universal dos médicos pelo Ministério da Saúde para universalizar o atendimento médico gratuito a toda população. O pagamento seria feito pelo Estado diretamente aos profissionais sem intermediários.
- E)** O movimento da reforma sanitária brasileira inseria-se na luta pela redemocratização do país, contra o domínio do campo da saúde pelo chamado complexo médico-industrial e contra a mercantilização da medicina.

**75.** No Brasil, o número de pessoas que devem ser adscritas a uma Equipe de Saúde da Família, conforme a Política Nacional de Atenção Básica de 2006, e sua relação aproximada com esse número em outros países com Atenção Primária forte é:

- A)** Em média 2500 e no máximo 3000 pessoas, sendo equivalente à maioria desses países.
- B)** Em média 3000 e no máximo 3500 pessoas, sendo menor que a maioria desses países.
- C)** Em média 3000 e no máximo 4000 pessoas, sendo maior que a maioria desses países.
- D)** Em média 3500 e no máximo 4000 pessoas, sendo equivalente à maioria desses países.
- E)** Em média 4000 e no máximo 4500 pessoas, sendo maior que a maioria desses países.

**76.** Em relação à educação em saúde na prática médica, assinale a alternativa correta.

- A)** As diferenças sociais e culturais entre usuários e médicos no Brasil são desprezíveis para a educação em saúde, dada a boa integração nacional, cultural e linguística do país.
- B)** Uma postura mais dialogal, contextualizadora da realidade existencial do paciente e participativa na relação médico-paciente tem sido considerada fundamental para melhorar essa relação e seus componentes educativos.
- C)** O principal obstáculo na educação em saúde deriva da dificuldade de os profissionais manterem-se atualizados devido à rápida inovação nos conhecimentos e tecnologias científicas na medicina.
- D)** A principal dificuldade para a educação em saúde é a baixa escolaridade da população brasileira.
- E)** Uma das principais tarefas para a educação em saúde é afastar os usuários pobres das crenças e superstições comuns em seu meio, diminuindo assim a utilização de tratamentos populares não validados cientificamente.

**77.** Assinale a alternativa correta, sobre questões históricas e sócio culturais da saúde.

- A)** A produção dos antibióticos e dos anti-inflamatórios foi o mais importante fator de melhora da saúde nos últimos dois séculos na Europa.
- B)** O conceito ampliado de saúde, que a pensa como dependente fortemente de determinações sociais, é uma perspectiva inaugurada no fim do século 20 e que não tem precedentes históricos na Europa.
- C)** O conceito de eficácia simbólica nasceu dos estudos da medicina baseada em evidências, que mostraram ser ele pouco importante para a maioria dos adoecimentos comunitários.
- D)** A prática médica está relacionada com o fenômeno chamado "medicalização social", o qual induz um excesso de realização de intervenções diagnósticas e terapêuticas e diminui a autonomia das pessoas no seu autocuidado autônomo.
- E)** O forte avanço tecnológico da medicina científica nos países desenvolvidos gerou uma recente diminuição da procura por outras formas de cuidado e tratamento (ditas medicinas alternativas e complementares) nesses países.

**78.** Sobre a Atenção Primária a Saúde (APS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar:

- A)** A função filtro da APS significa que ela deve prover o acesso aos cuidados e tecnologias de outros profissionais e serviços do Sistema de Saúde somente aos usuários que não possam pagar por esses cuidados.
- B)** No Brasil, a regulamentação relativamente recente dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) é um passo na direção de maior integralidade na atenção e na construção de poder de coordenação do cuidado na ESF.
- C)** O acesso fácil na APS está relacionado ao princípio da universalidade e na ESF ele é realizado em atendimento domiciliar para todos os usuários sem privilégios ou discriminações.
- D)** Organizar o sistema de saúde baseado na Atenção Primária à Saúde (APS) é uma forma de organização comum nos países ricos porque eles têm recursos para isso, já que essa forma de organização é cara e consome muita tecnologia.
- E)** Não há evidências científicas de que países desenvolvidos com uma APS forte têm índices de saúde-doença melhores do que os países que não têm.

**79.** Um paciente diabético, começou a apresentar vômitos sanguinolentos às 6h da manhã, a partir das 8h com tonturas e desmaios. Às 10h chegou ao Pronto-Socorro levado pela família descorado +++/4+ e PA de 0 mmHg. Paciente portador de esquistossomose mansônica há 5 anos, com internações há dois anos por vômitos de sangue com diagnóstico de varizes esofageanas após endoscopia. Às 12 horas apresentou parada cardiorrespiratória e faleceu, após insucesso das manobras de reanimação. A sequência correta a ser assinalada na Declaração de Óbito, de cima para baixo (da causa imediata ou terminal para a causa básica, incluindo por último outras condições que contribuíram para a morte) é:

- A)** Esquistossomose mansônica; hipertensão portal; rotura de varizes esofageanas; choque hipovolêmico; diabetes mellitus.
- B)** Diabetes mellitus; choque hipovolêmico; rotura de varizes esofageanas; hipertensão portal; esquistossomose mansônica.
- C)** Rotura de varizes esofageanas; choque hipovolêmico; esquistossomose mansônica; hipertensão portal; diabetes mellitus.
- D)** Esquistossomose mansônica; hipertensão portal; diabetes mellitus; rotura de varizes esofageanas; choque hipovolêmico.
- E)** Choque hipovolêmico; rotura de varizes esofageanas; hipertensão portal; esquistossomose mansônica; diabetes mellitus.

**80.** O Sr. Luís, 62 anos, procura a equipe de Saúde da Família de seu bairro no meio da tarde dizendo que está passando mal, cansado, muita falta de ar e com as pernas inchadas. Ao ser recebido, a enfermeira é chamada e percebe que o paciente é obeso, está bastante dispneico, com os pés e tornozelos inchados. Ele diz ser diabético, hipertenso, sofrer do coração e ter terminado seus medicamentos há duas semanas. O médico da equipe está em atendimento com a agenda cheia até o fim do expediente. Considerando as informações acima, a Política Nacional de Humanização do SUS, a proposta do Acolhimento e a missão de resolutividade da atenção básica, assinale a alternativa com a conduta adequada a ser tomada pela equipe de enfermagem.

- A)** Agendar uma consulta de rotina com o médico, que terá vaga após 25 dias.
- B)** Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) imediatamente, sem atrapalhar o médico.
- C)** Solicitar retorno para o dia seguinte, garantido uma vaga de urgência (encaixe) para o paciente.
- D)** Chamar o médico para uma avaliação e possível intervenção naquela mesma tarde, explicando que se trata de uma situação especial que requer sua atenção.
- E)** Encaminhar por escrito o Sr. Luís para o Pronto Atendimento ou Pronto-Socorro mais próximo, pois o paciente precisa de cuidado médico com urgência.

**81.** Um paciente jovem de 20 anos, sem comorbidades, apresenta tosse produtiva purulenta, febre de até 38°C, com três dias de evolução, e há um dia com dor torácica ventilatório-dependente em região posterior de hemitórax direito. No exame físico, sinais vitais dentro da normalidade, sem dispneia, SPO2 97% em ar ambiente e ausculta pulmonar com estertores em região posterior do hemitórax direito. RX tórax evidencia consolidação de todo o lobo inferior direito. Segundo o guidelines Pneumonia Adquirida na Comunidade - ATS/IDSA 2007, a melhor conduta para este paciente é:

- A)** Iniciar tratamento antibiótico com macrolídeo e controlar ambulatorialmente.
- B)** Internar o paciente e iniciar sulfa em dose específica para tratamento de pneumocistose.
- C)** Internar paciente em UTI para monitorar evolução clínica e iniciar tratamento com cefalosporina de terceira geração.
- D)** Internar paciente em UTI e iniciar tratamento com quinolona respiratória.
- E)** Realizar broncofibroscopia com lavado de lobo inferior direito e aguardar cultura do agente etiológico para iniciar antibiótico.

**82.** Considere um paciente de 25 anos, com história de asma desde infância, mas sem tratamento regular. Chega à consulta relatando uso diário de beta agonista, dispneia aos moderados esforços, tosse seca e sibilos à ausculta pulmonar. Espirometria evidencia limitação moderada ao fluxo de ar, com VEF1 52% previsto pré bd. Assinale a melhor opção de tratamento para este paciente.

- A)** Aminofilina, corticoide oral e anticolinérgico.
- B)** Beta agonista de curta e de longa duração.
- C)** Corticoide inalado dose baixa e beta agonista de curta duração para crises.
- D)** Corticoide oral e corticoide inalado.
- E)** Corticoide oral, corticoide inalado, beta agonista de longa duração, beta agonista de curta duração para crises.

**83.** Um paciente com 83 anos está internado há 30 dias por sepse urinária. A avaliação do prontuário permite a constatação de que o doente era acamado (antes da internação) e apresentava sequela neurológica importante por múltiplos acidentes vasculares cerebrais. Está acompanhada por sua filha, que mostra-se tranquila. Apresenta um novo quadro de sepse, provavelmente de origem pulmonar, e está evoluindo com insuficiência respiratória. Qual a conduta mais adequada para o caso, tanto do ponto de vista ético quanto técnico?

- A)** Explicar para a acompanhante sobre o prognóstico do quadro clínico, questionando-a a respeito de suas expectativas. Planejar ações paliativas, promovendo primordialmente o conforto do paciente.
- B)** Chamar o intensivista de plantão para avaliar internação na UTI pela necessidade de ventilação mecânica.
- C)** Comunicar para a filha do paciente que não há vaga na UTI e, por esse motivo, o tratamento será efetuado na enfermaria.
- D)** Promover entubação orotraqueal para o conforto do paciente.
- E)** Seguir o surviving sepse campaign.

**84.** No que concerne às diretrizes da American Heart Association 2010, para ressuscitação cardiopulmonar, em casos de Parada Cardiorrespiratória (PCR), é correto afirmar:

- A)** A profundidade da compressão mínima deve ser de 3 cm.
- B)** A frequência de compressão deve ser aproximadamente de 100/minuto.
- C)** O A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas) deve ser substituído para C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração).
- D)** Cuidados Pós-PCR integrados não fazem parte do elo da cadeia de sobrevivência de adulto.
- E)** Durante as manobras de reanimação a ventilação deve ser sempre privilegiada.

**85.** Um paciente de 35 anos chega à emergência com história de palpitações e sensação de que “o coração parece que quer sair pela boca”. Sua pressão arterial é estável, o ritmo é regular e a frequência cardíaca é de 150 bpm. O eletrocardiograma mostra uma taquiarritmia de complexo estreito. Qual o diagnóstico mais provável e qual a terapêutica de escolha?

- A)** Fibrilação atrial; Fazer cardioversão com 300J.
- B)** Taquicardia supraventricular; Administrar adenosina endovenosa.
- C)** Flutter atrial; fazer verapamil endovenoso.
- D)** Taquicardia ventricular; fazer adenosina endovenosa.
- E)** Fibrilação atrial; fazer cedilanide endovenoso.

**86.** Levando em consideração o “surviving sepsis campaign” (Intensive Care Medicine 2010; 36:222-231), é correto afirmar:

- A)** Faz parte do pacote das primeiras 6 horas de tratamento a administração de corticosteroides.
- B)** Para a restauração da pressão arterial, a administração de coloides mostra vantagens em comparação com a de cristaloides.
- C)** Uma meta a ser alcançada é a Saturação Venosa Central maior que 65%.
- D)** Nas primeiras 6 horas de tratamento, após a ressuscitação inicial com reposição volêmica, deve ser associada a administração de noradrenalina para a manutenção de uma pressão arterial média maior que 6.5 mmHg.
- E)** No pacote das primeiras 6 horas de tratamento deve ser administrada insulina endovenosa contínua para a manutenção de uma glicemia menor que 100 mg/dl.

**87.** No que concerne à insuficiência respiratória, é correto afirmar:

- A)** Para o diagnóstico de SARA é necessário que o índice  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  seja menor que 300.
- B)** Uma gasometria arterial com um  $\text{pCO}_2 > 50$  mmHg e um  $\text{pO}_2 < 60$  mmHg indica a entubação orotraqueal imediata associada à ventilação mecânica para pacientes com qualquer tipo de insuficiência respiratória.
- C)** Ao ajustar um ventilador em um paciente entubado de urgência por insuficiência respiratória, devem ser priorizadas pressões de platô e de pico menores que 40 mmHg.
- D)** Um paciente com distúrbio de nível de consciência + hipóxia importante + hipercapnia deve ser imediatamente submetido à ventilação mecânica não invasiva (BIPAP).
- E)** Em um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada por broncopneumonia, a indicação da entubação orotraqueal e ventilação mecânica é o distúrbio do nível de consciência associado à acidose, avaliada pela gasometria arterial ( $\text{pH} < 7.3$  cm H<sub>2</sub>O).

**88.** Um paciente masculino, 58 anos, hipertenso e diabético, iniciou há 6 meses com dispneia progressiva, atualmente aos mínimos esforços, acompanhada de ortopneia e edema de membros inferiores. O ecocardiograma mostra Fração de Ejeção do VE = 35%. Em qual estágio de doença se encontra este paciente (considerando-se a classificação da Insuficiência Cardíaca Congestiva baseada na progressão da doença) e qual o melhor tratamento para o caso?

- A)** Estágio A / diurético.
- B)** Estágio B / diurético + betabloqueador + inibidor da ECA.
- C)** Estágio C / diurético + betabloqueador + inibidor da ECA + antagonista da aldosterona.
- D)** Estágio D / diurético + betabloqueador + inibidor da ECA.
- E)** Estágio E / diurético + betabloqueador + inibidor da ECA + antagonista da aldosterona.

**89.** Um homem de 40 anos, assintomático, procura a atenção primária para avaliação clínica de rotina. Verifica-se que sua pressão arterial se encontra elevada : PA = 160/90 mmHg no início e ao final da consulta. O paciente retorna em uma semana e os valores de PA mantêm-se nos mesmos níveis da primeira consulta. Você realiza um exame de fundo de olho que evidencia retinopatia hipertensiva grau II na classificação de Keith e Wegener. Qual a conduta adequada frente a esta situação?

- A)** Confirmar HAS em 6 meses.
- B)** Iniciar tratamento farmacológico para hipertensão imediatamente.
- C)** Orientar dieta pobre em sal e modificações do estilo de vida.
- D)** Investigar outras lesões de órgão alvo para definir indicação de tratamento farmacológico para HAS.
- E)** Realizar monitoração ambulatorial da pressão arterial.

**90.** Um homem de 28 anos iniciou há 3 semanas com odinofagia, febre constante de 38 graus, mialgias, cefaleia. Percebeu também a presença de úlceras na mucosa oral. Relata relações sexuais desprotegidas frequentes nos últimos 2 meses. Realizou anti-HIV há 6 meses, que foi negativo. O médico avança a hipótese de Infecção Aguda pelo HIV. Qual (is) exame (s) laboratorial (is) pode (m) confirmar este diagnóstico?

- A)** Imunofluorescência indireta negativa para HIV.
- B)** Enzima Imunoensaio (ELISA) positivo para HIV.
- C)** Contagem de linfócitos CD4 menor que 300 cel/microl e carga viral > 100.000 cópias.
- D)** Sorologia para HIV negativa e antígeno p24 positivo.
- E)** Sorologia para HIV positiva e carga viral < 100.000 cópias.

**91.** Um paciente masculino, 45 anos, iniciou com odinofagia e febrícula; 2 dias após apresentou hematúria franca. O exame parcial de urina evidencia a presença de hemácias, cilindros hemáticos e proteínas +. Qual o diagnóstico mais provável?

- A)** Nefropatia por IgA.
- B)** Cistite hemorrágica.
- C)** Glomerulonefrite pós-infecciosa.
- D)** Púrpura de Henoch-Schönlein.
- E)** Granulomatose de Wegener.



**92.** Analise as afirmativas abaixo, em relação à análise do líquido cérebro-espinhal (LCE) obtido através de punção lombar: 1. A análise do LCE é importante para o diagnóstico de hemorragia subaracnoide. 2. O aumento do número de leucócitos no LCE acontece nas infecções, nas doenças inflamatórias e nos casos de carcinomatose meníngea. 3. O aumento do número de leucócitos no LCE com predomínio de polimorfonucleares sugere infecção bacteriana ou fúngica. 4. A concentração de glicose no LCE está tipicamente reduzida nas infecções bacterianas e fúngicas. 5. A concentração proteica no LCE está elevada numa variedade de doenças, incluindo muitas infecções e neuropatias desmielinizantes. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A)** São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- B)** São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- C)** São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- D)** São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- E)** São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

**93.** Assinale a alternativa correta entre a associação de achado hematoscópico com o respectivo significado clínico:

- A)** Formação de Rouleaux; infecção crônica.
- B)** Esquizócitos; anemia hemolítica microangiopática.
- C)** Hipossegmentação nuclear leucocitária; anemia megaloblástica.
- D)** Granulações tóxicas neutrofílicas; saturnismo.
- E)** Mieloblastos; leucemia linfoblástica aguda.

**94.** Analise as afirmativas abaixo em relação às drogas utilizadas no tratamento do Diabetes Mellitus tipo II: 1. A metformina, assim como as demais sulfonilureias, deve ser utilizada preferencialmente antes das refeições. 2. A grande vantagem das sulfonilureias de segunda geração (ex.: glimepirida) sobre as de primeira (ex.: tolbutamida) é que promovem uma queda da hemoglobina glicosilada (HbA1c) duas a três vezes mais acentuada. A grande desvantagem é o preço bem mais elevado. 3. Virtualmente todos os pacientes com Diabetes tipo II respondem inicialmente ao uso de sulfonilureia, estando a falência primária abaixo de 1%. 4. Os principais efeitos colaterais das sulfonilureias são a hipoglicemia e o ganho de peso. 5. Os inibidores da Dipeptidil Peptidase (DPP) IV (ex.: sitagliptina) atuam aumentando a secreção de insulina e diminuindo a secreção de glucagon. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A)** São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- B)** São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- C)** São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- D)** São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- E)** São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**95.** O hipertireoidismo subclínico é caracterizado laboratorialmente por:

- A)** TSH normal, T3 Livre levemente aumentado e T4 Livre também levemente aumentado.
- B)** TSH levemente aumentado, T3 Livre normal e T4 Livre também normal.
- C)** TSH suprimido, T3 Livre aumentado e T4 Livre também aumentado.
- D)** TSH suprimido ou aumentado, T3 Livre normal e T4 Livre levemente aumentado.
- E)** TSH suprimido, T3 Livre dentro do limite da normalidade e T4 Livre dentro do limite da normalidade.

**96.** Em relação aos medicamentos psicoativos, é correto afirmar:

- A)** Os benzodiazepínicos são recomendados como tratamento de primeira linha no delírio.
- B)** Os neurolépticos não devem ser usados no controle do delírio.
- C)** O haloperidol usado por via parenteral não causa efeitos colaterais extrapiramidais.
- D)** Delírio e comprometimento cognitivo são os efeitos adversos mais frequentes dos medicamentos psicoativos.
- E)** Os benzodiazepínicos de longa duração como flurazepan e diazepam são medicações com poucos efeitos colaterais e devem ser a primeira escolha no controle da insônia nos idosos.

**97.** Paciente de 15 anos, masculino, branco, que desde os 4 anos de idade apresenta manchas eritematosas descamativas, às vezes com pequenas vesículas, escoriações, crostas, intensamente pruriginosas, de caráter recorrente, localizadas principalmente na área periorbital e áreas flexoras. O paciente ainda refere que apresenta rinite eventualmente e que seu irmão mais velho apresenta as mesmas lesões de pele e é asmático. Qual o diagnóstico mais provável?

- A)** Dermatite Atópica.
- B)** Dermatite Numular.
- C)** Dermatite Seborreica.
- D)** Dermatite Actínica Crônica.
- E)** Dermatite de Contato.

**98.** Considere um paciente do sexo masculino, 67 anos, com quadro de epigastralgia em queimação há 3 meses. Refere que os sintomas pioram com o jejum e melhoram com a alimentação, além de acordarem eventualmente durante a noite. Refere, também, emagrecimento de 6 kg no período. Nega outras queixas. Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral, hipocorado +/4, hidratado, anictérico, acianótico e afebril. Não havia alterações no exame físico cardiorrespiratório e abdominal. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta.

- A)** Como os sintomas são altamente sugestivos de doença ulcerosa péptica, a melhor abordagem seria tratamento empírico com omeprazol.
- B)** Está indicada a realização de endoscopia digestiva alta para investigação da causa dos sintomas dispépticos.
- C)** Devido à alta prevalência de infecção pelo *H. pylori* em nosso meio, o tratamento empírico de erradicação desta bactéria está indicado neste caso.
- D)** A ultrassonografia e a radiografia simples de abdome são exames baratos, simples, e que, neste caso, estariam indicados inicialmente para avaliação diagnóstica.
- E)** Uma dieta livre de irritantes gástricos é extremamente eficaz nos casos em que existe suspeita de doença gástrica estrutural (por exemplo, doença ulcerosa péptica), e deve ser recomendada como única medida inicial neste caso.

**99.** Uma paciente do sexo feminino, 37 anos, procura atenção médica por sorologia positiva para hepatite C detectada na doação de sangue. Nega sintomas e não possui antecedentes clínicos ou cirúrgicos significativos, a não ser por uma transfusão de sangue aos 4 anos de idade por “anemia profunda” após um quadro de pneumonia. O exame físico é normal. Os exames laboratoriais mostram: anti-HCV: reagente / ALT: 37 (normal até 42) / AST: 31 (normal até 38). Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta.

- A)** Como as aminotransferases estão normais, não há necessidade de novos exames laboratoriais.
- B)** A hepatite C raramente é assintomática; portanto, trata-se provavelmente de um exame de anti-HCV “falso-positivo”.
- C)** A única maneira de confirmar a infecção pelo HCV é através da biópsia hepática, que estaria indicada neste caso independentemente das aminotransferases normais, já que até 30% dos portadores de hepatite C com aminotransferases normais têm lesão hepática significativa.
- D)** É necessária a complementação diagnóstica com o exame de HCV-RNA qualitativo.
- E)** O tratamento com ribavirina monoterapia estaria indicado neste momento para impedir a progressão da doença enquanto a paciente aguarda os demais exames necessários para avaliação do seu caso.

**100.** Uma paciente do sexo feminino, 19 anos, refere início há 2 dias de disúria, dor em baixo-ventre e há 1 dia dor lombar à direita e febre não aferida. Sem outras queixas. Nega comorbidades, uso de medicações ou quadros semelhantes no passado. Ao exame físico encontrava-se em regular estado geral, corada, hidratada, anictérica e acianótica. A temperatura axilar era de 39°C, pressão arterial 90 x 60 mmHg, frequência cardíaca 105 batimentos por minuto e frequência respiratória 22 incursões respiratórias por minuto. O sinal de Giordano (punho-percussão dolorosa da região lombar) foi positivo à direita. Não havia outras alterações no exame físico cardiorrespiratório e abdominal. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta.

- A)** Trata-se de um provável caso de infecção urinária não complicada e está indicado tratamento empírico com norfloxacin.
- B)** A paciente deve ser encaminhada para avaliação ginecológica com urgência, pois o quadro é altamente sugestivo de doença inflamatória pélvica.
- C)** Para evitar o aparecimento de cepas bacterianas resistentes, o tratamento com antibióticos deverá ser iniciado apenas após o resultado da urocultura e orientado especificamente para o germe isolado.
- D)** Como a paciente apresenta sintomas há menos de 3 dias, não há indicação de tratamento específico ou exames complementares, já que a maioria dos casos de infecção urinária melhora espontaneamente.
- E)** Devido ao quadro de sepse, a antibioticoterapia parenteral e hidratação devem ser iniciadas imediatamente com a paciente internada enquanto os exames laboratoriais estão em andamento.

## GABARITO

|               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1 - D</b>  | <b>2 - E</b>  | <b>3 - D</b>  | <b>4 - C</b>  | <b>5 - A</b>   |
| <b>6 - B</b>  | <b>7 - E</b>  | <b>8 - A</b>  | <b>9 - E</b>  | <b>10 - D</b>  |
| <b>11 - B</b> | <b>12 - E</b> | <b>13 - C</b> | <b>14 - —</b> | <b>15 - C</b>  |
| <b>16 - B</b> | <b>17 - E</b> | <b>18 - A</b> | <b>19 - C</b> | <b>20 - B</b>  |
| <b>21 - D</b> | <b>22 - A</b> | <b>23 - D</b> | <b>24 - E</b> | <b>25 - B</b>  |
| <b>26 - A</b> | <b>27 - C</b> | <b>28 - A</b> | <b>29 - C</b> | <b>30 - B</b>  |
| <b>31 - D</b> | <b>32 - A</b> | <b>33 - E</b> | <b>34 - D</b> | <b>35 - A</b>  |
| <b>36 - C</b> | <b>37 - B</b> | <b>38 - D</b> | <b>39 - E</b> | <b>40 - D</b>  |
| <b>41 - B</b> | <b>42 - C</b> | <b>43 - B</b> | <b>44 - C</b> | <b>45 - A</b>  |
| <b>46 - C</b> | <b>47 - D</b> | <b>48 - D</b> | <b>49 - C</b> | <b>50 - B</b>  |
| <b>51 - A</b> | <b>52 - B</b> | <b>53 - E</b> | <b>54 - C</b> | <b>55 - A</b>  |
| <b>56 - B</b> | <b>57 - D</b> | <b>58 - E</b> | <b>59 - C</b> | <b>60 - B</b>  |
| <b>61 - A</b> | <b>62 - A</b> | <b>63 - B</b> | <b>64 - C</b> | <b>65 - A</b>  |
| <b>66 - E</b> | <b>67 - D</b> | <b>68 - E</b> | <b>69 - C</b> | <b>70 - D</b>  |
| <b>71 - A</b> | <b>72 - E</b> | <b>73 - A</b> | <b>74 - E</b> | <b>75 - C</b>  |
| <b>76 - B</b> | <b>77 - D</b> | <b>78 - B</b> | <b>79 - E</b> | <b>80 - D</b>  |
| <b>81 - A</b> | <b>82 - E</b> | <b>83 - A</b> | <b>84 - C</b> | <b>85 - B</b>  |
| <b>86 - D</b> | <b>87 - E</b> | <b>88 - C</b> | <b>89 - B</b> | <b>90 - D</b>  |
| <b>91 - A</b> | <b>92 - C</b> | <b>93 - B</b> | <b>94 - C</b> | <b>95 - E</b>  |
| <b>96 - D</b> | <b>97 - A</b> | <b>98 - B</b> | <b>99 - D</b> | <b>100 - E</b> |

— : questão sem gabarito cadastrado na plataforma de origem (não anulada aqui, apenas indisponível).